Diskussion 570

Datum: 1928-05-16
Kammare: Första kammaren
Antal yttranden: 2
Källa: Tal om Kvinnor: Annotated Corpus (doi:10.5281/zenodo.18211787), byggd på The Swedish Parliament Corpus (Yrjänäinen m.fl. 2024).

Markerade ord: [1] kvinna-ord, [2] släktskaps- och tilltalsord, [3] yrkestitlar.

1. Jakob Pettersson (–, man)

Herr talman! Det förslag, som framlagts i föreliggande proposition, är resultatet av ett åttaårigt utredningsarbete.

År 1919 väcktes i riksdagen motioner, vari begärdes, att man skulle åstadkomma en genomgripande reform av lasarettssetadgan och tuberkulossjukhusstadgan samt andra författningar, vilka reglerade skötseln och förvaltningen av under landsting stående sjukvårdsanstalter. I anledning av deecssa motioner, som visserligen biföllos endast av andra kammaren, tillsattes av Kungl. Maj:t en kommitté, som efter två år avgav sitt betänkande. Det visade sig, att kommitténs ledamöter icke hade kunnat bli ense om förslaget utan det förelåg ett flertal reservationer. Betänkandet var, som man säger, ganska trasigt. Det utställdes till yttrande av vederbörande myndigheter och korporationer, och även ur dessas yttranden var det svårt att få fram något, som kunde närma sig enighet. Då uppdrogs det i slutet av år 1926 åt några sakkunniga att med ledning av sjukhusstadgekommitténs betänkande och de däröver avgivna yttrandena söka åstadkomma ett antagligt förslag. Denna sista sakkunnigberedning avgav ett enhälligt betänkande, och även de i ärendet närmaste intresserade korporationerna och myndigheterna ha i huvudsak tillstyrkt det däri framlagda förslaget.

Det är på grundvalen av detta förslag som Kungl. Maj:ts proposition utarbetats, och meningen vore att nu äntligen genom riksdagens bifall till propositionen få slut på den långvariga och föga tilltalande strid, som pågått rörande flera av de viktiga frågor, som det här gäller. Det är därför ganska smärtsamt att nu höra framställas ett yrkande, som går på rent avslag. Herr Reuterskiöld har gjort sig till talesman för det yrkandet. Som skäl för sitt yrkande har han åberopat en kritik av förslaget i vissa punkter. Herr Reuterskiöld opponerar sig först och främst mot förslaget om anordningen av förvaltningen av sjukhusens angelägenheter. Han anser, att det vore lyckligast, om förvaltningen samlades i landstingets förvaltningsutskotts hand. Vidare opponerar han sig mot förslaget att stryka landshövdingens självskrivenhet i lasarettsdirektionen. Ytterligare kritiserar han förslaget till regler om tillsättande av läkare enligt 11 $. Genom dessa bestämmelser, säger herr Reuterskiöld, öppnas dörren på vid gavel för medicinalstyrelsens godtycke. Och vidare klagar han särskilt över att lasarettsdirektionens rätt att ge förord genom förslaget inskränkts. Även klandrar han det sätt, på vilket man anordnat läkares befattning som sjukhusets styresman, och slutligen riktar han sin kritik mot bestämmelserna om läkares rätt till ersättning. I sistnämnda avseende tog herr Reuterskiöld

särskilt sikte på bestämmelsen i 12 8 om ordnandet av poliklinisk verksamhet. Han ansåg, att sjukhusläkaren ej borde få vara medbestämmande vid den sakens ordnande, utan den borde direktionerna få bestämma ensamma. Han fann det inte vara riktigt, att det enligt 15 $ inte skall kunna göras undantag från läkarens rätt att driva enskild praktik i så måtto, att han skall kunna förbjudas att ha någon mottagning i sin egen bostad. Slutligen klandrade han bestämmelserna i 19 8 om ersättning till lä-

kare från patienter på enskilt och halvenskilt rum, och han menade, att de nu- . Förslag varande bestämmelserna därvidlag vore att föredraga. Hill sjukhuslag;

Alla de av herr Reuterskiöld nu upptagna spörsmålen ha under den före- = (Fort gående beredningen noggrant och fullständigt utretts. Jag vill inte åtaga mig att nu i detalj redogöra för allt vad i detta avseende är sagt utan skall endast framställa några erinringar mot herr Reuterskiölds yrkande.

Vad då beträffar frågan om den ekonomiska förvaltningen av sjukhusen och önskemålet att lägga denna förvaltning mera fullständigt under landstingens förvaltningsutskott, vill jag hänvisa till vad som yttras i motiveringen till 1924 års förslag till lag om landsting. Där heter det: »Tyngdpunkten av sjukvårdsanstalternas ekonomiska förvaltning bör alltfort ligga hos de lokala styrelserna, vilka jämväl, utan inblandning från någon central länsmyndighet, böra omhänderhava de rena sjukvårdsangelägenheterna. Någon centralisering av den ekonomiska förvaltningen vid sidan av eller under förvaltningsutskottet bör ej heller få förekomma. En sådan anordning, exempelvis inrättande av överstyrelse för dessa anstalter, till vilken sammanfördes en del av den ekonomiska förvaltningen, skulle kvingskära förvaltningsutskottets befogenhet och allvarligt äventyra den enhetliga överblick över och ledning av förvaltningsapparaten, som man genom förvaltningsutskottet syftade att ernå. För bärarna av sjukvårdsintresset inom de olika anstalterna läkare och styrelser — synes det ock böra vara till gagn, att de ställas i närmare direkt kontakt med sin högsta huvudman, landstinget, genom dess förtroendemän, förvaltningsutskottet. Utskottets överinseende över förvaltningen kommer att med ett mera personligt intresse anknyta landstingens representanter till arbetet å sjukvårdens förkovran.» Denna ståndpunkt godtogs av departementschefen och godkändes också av riksdagen och föranledde den ändring, som då vidtogs i lagen om landsting. Genom detta beslut ha statsmakterna tagit ståndpunkt till frågan om fördelningen av den ekonomiska förvaltningen av sjuksen, och det nu föreliggande förslaget utgör endast eit byggande på denna grund.

I fråga om landshövdingens självskrivenhet i lasarettsdirektionen kan naturligtvis åtskilligt sägas både för och emot. Jag vill gentemot herr Reuterskiöld endast erinra, att landshövdingen även enligt det föreliggande förslaget ju äger deltaga i direktionens sammanträden och göra sin duglighet och sin förmåga gällande där. Man kan alltså icke säga, att han är utesluten från förvaltningen.

Vad läkartillsättningen beträffar, får väl herr Reuterskiöld erkänna, att det är en ytterst svår och delikat fråga. Olika meningar ha yttrats i densamma. Då man nu, trots de olika önskemål, som i denna sak framkommit, slutligen har lyckats att formulera ett förslag, som har godkänts under den föregående behandlingen såväl av svenska läkarförbundet som av landstingsförbundet, synes det mig ganska vågat att försöka slå sönder denna med möda åstadkomna kompromiss. Jag är övertygad om att varken landstingsförbundet eller läkarförbundet voro så utomordentligt förtjusta över kompromissen, men det är i alla fall en överenskommelse, som godtagits av bägge sidornas representanter, och då synes det mig icke vara skäl att förkasta den och ånyo släppa ut frågan till ytterligare utredning och ytterligare strid.

Detsamma gäller frågan om läkares befattning som sjukhusets styresman. Vad angår läkares rätt till honorar skall jag i annat sammanhang närmare ingå på den saken.

Jag måste säga, att det skulle vara beklagligt, om herr Reuterskiöld nu finge kammaren att gå med på hans avslagsyrkande. Det är dock så, att man även på andra håll än läkarnas anser sig ha skäl till missnöje med den nuvarande ordningen och i stor utsträckning är benägen att anse det föreliggande försla-

get som en väsentlig förbättring i jämförelse med den nuvarande ordningen. Jag fick i synnerhet ett mycket starkt intryck av att den allmänna uppfattningen är sådan vid landstingsförbundets sammanträde i höstas. VWVisserligen framfördes där från ett och annat håll kritik, men den allmänna uppfattningen var, att förslaget innebar ett verkligt framsteg.

Nu har utskottet i huvudsak tillstyrkt den kungl. propositionen. Den enda betydande avvikelse, som förekommer i utskottets utlåtande, rör läkares rätt till honorar av sina patienter. Detta är givetvis, som också herr Reuterskiöld framhöll, en mycket svår och invecklad fråga, och det är därför klart, att det skall finnas olika meningar om bästa sättet att lösa den. :

För närvarande gäller som bekant den ordningen, att läkare vid ett sjukhus inte får begära men väl är berättigad att mottaga ersättning av patienterna. Mot denna anordning anmärkes nu, att den sprider en för parterna mycket besvärande oklarhet över hithörande förhållanden. Det kan för närvarande inträffa, att en patient i god ekonomisk ställning, som vårdas på ett sjukhus, inte har fullt klart för sig, att det verkligen åligger honom såsom en moralisk skyldighet att ge särskild ersättning till läkaren utöver vad han får betala i legosängsavgift. Ännu vanligare är naturligtvis, att patienterna inte alls ha klart för sig, hur mycket de skola ge läkaren. Å andra sidan anser läkaren på goda skäl, att han har rätt att få ersättning av de patienter, som ha möjlighet till det, och han anser därför, om han får ett alltför ringa belopp, att han blivit lurad på vad han bör ha. För att få klara linjer på detta område och för att på samma gång söka åstadkomma en skälig ersättning åt läkaren för hans arbete utan att dock patienterna behöva alltför mycket betungas, föreslås i propositionen följande anordning:

Sanatorieläkare skola inte vara berättigade att vare sig begära eller mottaga ersättning av patienter. «Lasarettsoch sjukstugeläkare skola inte vara berättigade att mottaga ersättning av patienter på allmän sal. Lasarettsoch sjukstugeläkare skola ej vara berättigade att taga ersättning för åtgärder, som stå i samband med patients intagning eller utskrivning från sjukhus, med undantag dock för det fall att för intagning skett särskilt omfattande laboratorieundersökning. Vad sedan beträffar par tienter på enskilt och halvenskilt rum; så utgår propositionen ifrån att lasaretisdirektionerna och läkarna skola kunna träffa överenskommelse av innehåll, att läkaren icke skall taga något honorar av dylika patienter, naturligtvis då under den underförstådda förutsättningen att läkaren beredes kompensation genom förhöjning av lönen. Om däremot inte någon sådan överenskommelse träffats mellan läkaren och lasarettsdirektionen, skall läkaren vara berättigad att av patienter på enskilt och halvenskilt rum kräva ersättning, bestämd med hänsyn till vårdens art och patientens ekonomiska förhållanden. För att inte därigenom någon uppskörtning av patienterna skall kunna ske, föreslås att denna ersättning skall utgå efter en taxa, fastställd av medicinalstyrelsen.

Om denna anordning säger nu utskottet att utskottet biträder propositionens mening, att det är lämpligt att mellan lasarettsläkarna och lasarettsdirektionerna träffas överenskommelse i syfte att alldeles avskaffa rätten till honorar. Men om en sådan överenskommelse inte träffas, vill utskottet ej godkänna den i propositionen föreslagna anordningen. Utskottet anmärker, att om honorar bleve obligatoriskt, skulle det kunna inträffa, att en läkare inför rätta utsökte sitt honorar av en patient, vilket skulle strida mot en starkt rotad uppfattning. Å andra sidan skulle det kunna hända, att om en läkare tog för sig ett större honorar, än han enligt taxan var berättigad till, han kunde bli bötfälld för tjänstefel, vilket utskottet icke heller finner önskvärt. Utskottet föreslår därför, att i de fall, där överenskommelse mellan läkare och direktion icke träffats, det skulle få förbli vid den nuvarande anordningen, och läkare således vara berättigad att mottaga men icke att fordra arvode. Men det föreslås tillika

den nyheten, att till ledning för arvodets utgivande skulle av medicinalstyrel- Förslag. sen upprättas en taxa. Denna taxa skulle inte få bindande verkan utan endast ""! siukhluslag. tjäna till ledning för patienterna. Detta är utskottsmajoritetens förslag.

En ledamot av utskottet har tillstyrkt propositionen, och tre ledamöter från

andra kammaren framställa ett särskilt förslag. De utgå från den principen, att det riktiga är att något honorar från sjukhuspatienter alls icke förekommer. De vilja därför i detta avseende alldeles likställa patienter på enskilt och halvenskilt rum med patienter på allmän sal. 'Tillika uttalas, att en sådan anordning förutsätter, att läkarna få förhöjning av sina nu utgående löner, varvid reservanterna föreställa sig, att landstingen inte skulle lägga några svårigheter i vägen för en sådan anordning. På samma gång erkänna reservanterna, att det i Stockholm och vid en del större sjukhus kan förekomma behov av en annan anordning, och de vilja därför medge möjlighet för tillämpning av det system, som i propositionen föreslås, ifall Kungl.

Maj:t på vederbörlig framställning ger dispens. Det skulle således få bero på särskilt dispensbeslut, att utgående av honorar skall bli obligatoriskt. . Beträffande dessa olika förslag vill jag först yttra några ord om de tre sist omförmälda reservanternas ståndpunkt. Jag skall gärna instämma med reservanterna däruti, att det i och för sig vore önskvärt och mest tilltalande. om patienterna på sjukhus, vilken förmögenhetsställning de än hade, inte skulle behöva betala något särskilt för vården, utöver sin lagligen bestämda avgift, och att på samma gång läkarna finge en fullt tillräcklig avlöning av sina landsting. Men jag kan inte undertrycka den farhågan, att om reservanterna skulle få sin vilja fram och det bleve en anordning i överensstämmelse med deras förslag, den lön, som landstingen bestämde för lasarettsläkarna, ej alltid bleve tillräcklig. Läkarnas långvariga och dyrbara utbildning, deras även efter examen fortsatta kostsamma studier och .deras mycket slitande och ansvarsfulla arbete medföra krav på en icke alltför låg lön. Om nu landstingen skulle ställas inför en uppfordran att höja läkarnas löner för att möjliggöra ett fullständigt avskaffande av honorarsystemet, vore det nog inte så märkvärdigt, om ett eller annat landsting skulle draga sig för att sätta lönen tillräckligt hög, i synnerhet om det gällde att ta ut denna ökade avlöning i form av ett plus till en kanske förut hög landstingsskatt. Och att till någon mer avsevärd del lägga den för läkarna avsedda höjningen på legosängsavgifterna torde väl inte heller vara så tilltalande.

Vad så utskottsförslaget beträffar, skulle det ju i huvudsak, såvitt jag kan se, innebära ett bevarande av det nuvarande systemet, så att läkare, om inte överenskommelse träffades, skulle vara berättigad att mottaga men inte att kräva ersättning. Skillnaden mot det nuvarande tillståndet skulle ligga i den rådgivande taxan, men jag är rädd för att denna inte skulle få så stor betydelse, som utskottet föreställer sig.

Jag har beträffande denna fråga sökt erhålla underrättelse om, hur den andra parten ställer sig. I utskottsbetänkandet ha huvudsakligen landstingens synpunkter gjorts gällande, men det kan inte nekas, att även den andra: parten, läkarna, ha rätt att fordra att få sina synpunkter framförda, då det gäller att göra om det förslag, som föreligger. Jag har därför vänt mig till representativt läkarehåll och frågat, hur läkarna betrakta utskottsförslaget. Då har man sagt mig, att om utskottsförslaget antages, så är det att vänta att flertalet eller åtminstone en mycket stor del av de nuvarande lasarettsläkarna skulle bestämt motsätta sig att ingå på en överenskommelse om en taxereglerad betalning för poliklinisk verksamhet enligt 12 $, ty en sådan anordning, som där föreslås, lära lasarettsläkarna i regel anse för sig allt annat än förmånlig. Skulle de vara villiga att gå med på den, så skulle de åtminstone fordra, att de sakkunnigas och regeringens förslag om rätt till honorar enligt 19 $

inte försämras. Om nu läkarna skulle intaga en sådan position, så ha ju landstingen i sin makt att säga: Då få inte herrarna använda våra lokaler, våra instrument, våra **sjuksköterskor**[3] o. s. v. Men då ligger det nära till hands för läkarna att svara: Ja, då flytta vi mottagningen till våra bostäder, såsom också redan lär ha skett i ett par fall. Jag vill med anledning härav för egen det säga, att det synes mig uppenbart, att en lagstiftniug i överensstämmelse med

utskottsförslaget ej torde lösa denna fråga. Man kommer fortfarande att ha denna strid mellan landstingen och läkarna, och det förefaller icke tilltalande. Meningen med propositionen har just varit, att däri framställda förslag, betraktade såsom ett helt, skulle åstadkomma en slutuppgörelse i denna strid. Det är därför, som jag icke utan en viss farhåga motser ett beslut enligt utskottsförslaget.

På samma gång anser jag mig böra säga, innan jag går ner härifrån, att om man ställes inför valet mellan andrakammarreservationen och utskottsförslaget, så är nog utskottsförslaget fvgjort att föredraga, ej blott ur läkaresynpunkt utan även ur landstingens och allmänhetens synpunkt. Ty det är klart, att om en lag kommer till stånd, som alltför kraftigt beskär läkarnas intressen, så kan påföljden bli den, att de skickligaste och bästa läkarna draga sig för att ägna sig åt sjukhusläkarens bana och i stället slå sig på privatpraktik. Ett sådant resultat är naturligtvis inte till gagn för dem, som skola vårdas på sjukhusen.

2. Karl Gustaf Westman (–, man)

Herr talman! Den förste ärade talaren framhöll, att utskottsförslaget, som i det väsentliga utgör ett tillstyrkande av propositionen, innebär ett framsteg i flera olika avseenden. Särskilt framhöll han härvid de regler, som där ges rörande läkares tillsättning. Den andre ärade talaren däremot fann, att man inte kunde fälla det omdömet om propositionen, att den införde en tillfredsställande reglering av förhållandena på det område, varom här är fråga, och han slutade med att yrka avslag på förslaget i dess helhet. Jag ber att med anledning av detta avslagsyrkande få framställa några anmärkningar. Jag kan fatta mig jämförelsevis kort, eftersom herr statsrådet redan till bemötande upptagit en hel del av de invändningar som gjorts.

Gentemot den sist nämnde ärade kammarledamotens uttalande, att utskottsförslaget inte innebär någon tillfredsställande reglering av de ekonomiska förhållandena mellan landstingens förvaltningsutskott å ena sidan och direktionerna å den andra, måste jag framhålla, att i jämförelse med det tillstånd, som nu råder, innebär utskottsförslaget ett betydande framsteg. Förslaget går ju ut därpå, att förvaltningsutskottet skall utöva makten över sjukhusen genom att ge de allmänna direktiven och tillsätta direktionen. Däremot har man inte velat gå så långt som därhän, att förvandla förvaltningsutskotten till verkställande korporationer, utan man har ansett, att om man skulle få en direktion, som med intresse och nit ägnade sig åt sin uppgift, så borde åt direktionen överlämnas en viss frihet att enligt förvaltningsutskottets direktiv handha den löpande förvaltningen. Skulle det visa sig att direktionen handhade detta förtroendeuppdrag på ett olämpligt sätt, så stode det ju landstinget fritt att vidtaga en personförändring. Jag tror för min del att saken därmed blir ordnad på ett sätt, som fullt tillgodoser de önskemål, som man kan hysa från landstingshåll. Mig veterligt ha ej heller de, som yttrat sig i ärendet från landstingens sida, framställt några anmärkningar mot den lösning, som förslaget innebär i detta avseende.

Jag ber vidare att få påpeka, att när den ärade talaren framhöll som en brist i förslaget att det lämnade läkaren ett alltför stort ekonomiskt inflytande, så får man inte förbise, att förslaget

även därvidlag ur den synpunkt,

som han gjorde till sin, innebär ett framsteg. Det är nämligen så, att enull da ligt förslaget stärkes direktionens ställning i förhållande till läkaren i flera Forte) 7 ÅA 2:

avseenden, bland annat därigenom att förslaget lämnar anvisning på en utväg för direktionen att kunna tillsätta en delegation, som vid styresmannenläkarens sida deltar i behandlingen av de ärenden, som denne har att avgöra, om dessa ärenden äro av något större betydelse. Vidare har direktionen fått sin maktställning stärkt genom bestämmelsen att sjukvårdspersonalen hädanefter skall avskedas av direktionen och icke av läkaren. Genom sist anförda bestämmelse har också sjukvårdspersonalens ställning stärkts gentemot läkaren. Förslaget innehåller därjämte andra bestämmelser, som stärka sysslomannens ställning i förhållande till läkaren. Den ärade talaren behagade således finna, att även om förslaget inte går så långt, som han skulle önska, så innehåller det i alla fall åtskilliga bestämmelser, som visa att man har beaktat de synpunkter, som han gjort sig till talesman för, i den mån man ansett klokt att göra det, vid denna nya lagstiftning.

Den ärade talaren övergick därefter till att framställa invändningar mot förslaget med hänsyn till de regler, som däri meddelas rörande läkares möjlighet att erhålla honorar. Först vände sig då den ärade talaren mot de bestämmelser, som finnas i förslagets 12 $ och som handla om införande av en taxebunden poliklinisk verksamhet. Den ärade talaren klagade över att förslaget inte innehöll en bestämmelse om att landstingen skulle äga att avgöra, huruvida en sådan poliklinisk verksamhet skulle utövas av läkaren eller inte. Men det är givet, att när landstinget anslår en plats ledig, kan landstinget i avlöningsvillkoren införa en bestämmelse om att en sådan poliklinisk verksamhet skall utövas av läkaren och även på förhand tillkännage de förutsättningar, under vilka förhållanden han skall utöva denna polikliniska verksamhet. Man kan däremot inte gå så långt, att man säger i lagen att en sådan taxebunden poliklinik under alla förhållanden skall finnas, ty det kan ju tänkas fall, då en sådan inte är behövlig vid ett sjukhus.

Vidare framställde den ärade talaren anmärkningar rörande 15 $, som handlar om läkares rätt att utöva enskild praktik. Jag kan kanske gå förbi vad den ärade talaren därvidlag yttrade, ty även den förste ärade talaren berörde den frågan, och han tillkännagav sin avsikt att återkomma därtill under detaljbehandlingen. Den sak det här gäller kan naturligtvis inte anses vara av den betydenhet, att den återverkar på frågan huruvida man skall avslå eller icke avslå det föreliggande förslaget.

Vad slutligen beträffar den tredje faktor, som spelar in, när det gäller storleken av läkares inkomster från allmänheten, möter man den i 19 S$. Det gäller där läkares rätt att mottaga arvode för vård av patienter, som intagits på sjukhus. Jag ber att först få fästa uppmärksamheten på att såväl Kungl. Maj:ts proposition som utskottsförslaget innebär ett avgjort framsteg i jämförelse med det nuvarande förhållandet, därutinnan att enligt båda

dessa förslag är det förbjudet för läkare att mottaga någon som helst ersättning av patienter på allmän sal. Något sådant förbud finns ju inte nu, utan det förekommer på vissa håll, att patienter på allmän sal ha ansett sig böra överlämna ett honorar till läkaren, även om det naturligtvis varit så, att läkaren inte haft rätt att fordra något. Men nu skulle det alltså bli förbud för honom att mottaga något från patienter på allmän sal. Det är ju ett stort framsteg, ett viktigt framsteg. Denna bestämmelse berör det stora flertalet av sjukhuspatienter och medför att alla de, som äro mindre bemedlade, komma ifrån varje känsla av förpliktelse att lämna någon ersättning till läkaren. Däremot gäller ju något annat både enligt utskottsförslaget och enligt Kungl. Maj:ts förslag beträffande de patienter, som vårdas på halvenskilt eller enskilt rum. Härvid är dock att märka, att om en person, som

är i det ekonomiska läge, att han egentligen skulle vara allmänsalspatient, är så sjuk, att han inte lämpligen kan vårdas på allmän sal utan av denna anledning lägges in på särskilt rum, så gäller naturligtvis för honom huvudregeln, att han inte skall betala något läkarhonorar. Regeln, att visst honorar skall kunna utgå från patienter, gäller alltså endast sådana patienter, som ligga på halvenskilt eller enskilt rum, därför att de anse sig ha råd att skaffa sig en sådan förmån. Det har förefallit oss, som om det inte skulle vara obilligt, att man ställde det så, att dessa patienter under viss förutsättning skulle känna sig manade att betala läkararvode till den läkare, som har skött dem. Det är en väg, som jag vågar tro ej är mera odemokratisk än den, att man lägger ett avlöningsbelopp till läkaren motsvarande avgifterna på debetsedlarna.

Emellertid har utskottet ej sagt, att en sådan anordning som den, vilken jag

förordar, nödvändigtvis skall träffas, utan utskottet har ställt sig på den ståndpunkten, att landstinget i varje särskilt fall skall avgöra, huruvida landstinget vill hava det ställt på det sättet, att läkaren ej skall få taga emot några som helst avgifter från patienterna, var de än må ligga, eller på det sättet, att han skall få göra det i viss begränsad omfattning. Vi ha tänkt oss, att det skulle vara mycket lämpligt, att landstingen hade en sådan frihet, därför, att då kunna ju landstingen, när de anslå en tjänst ledig till ansökan, avväga på vilket sätt de anse, att en i det stora hela lämplig inkomst skall komma att tillfalla läkaren. De kunna avväga, huru mycket de vilja giva honom i lön och taga hänsyn till hur mycket han kan beräknas få på polikliniken samt hur mycket han kan få in genom vård av patienter på halvenskilt och enskilt rum. LDLandstingens organ skulle nämligen göra upp förslag till taxor. De kunna alltså betrakta alla inkomstfaktorer i ett sammanhang. På det viset få landstingen möjlighet att bereda läkaren den totalinkomst, som de finna vara lämplig. Det har emellertid även i denna kammare uttalats olika meningar rörande den lösning av frågan om läkarens rätt till arvode från patienter på halvenskilt och enskilt rum, som utskottet föreslagit. Herr Reuterskiöld yttrade, att när utskottet föreslagit, att det skall utfärdas en rådgivande taxa, blir följden den, att patienterna komma att betala i lika stor utsträckning, som om man hade en obligatorisk taxa, sådan som återfinnes i propositionen. Statsrådet uttalade däremot den åsikten, att om man införde en rådgivande taxa, så komme en hel del av patienterna att underlåta att betala. För min del tror jag, att vare sig man har en rådgivande eller en obligatorisk taxa, så blir

resultatet med avseende å den slutinkomst, som tillkommer läkaren, ungefär detsamma, ifall själva taxesatserna äro lika höga. Det är nog möjligt, att en och annan patient använder sig av den rätt, som meningen är, att han skall ha vid en rådgivande taxa, så att han ej betalar vad som står i taxan utan säger: »Min ekonomi tillåter mig inte att betala så mycket; därför gör jag det inte.» Det är dock antagligt, att om en eller annan patient gör så, detta uppväges därav, att i stället en eller annan patient betalar något mera än vad han enligt taxan strängt taget skulle väntas betala, och en sådan frivilligt påtagen utgift kan man ju ej ur demokratisk synpunkt eller ur lagstiftningssynpunkt överhuvud taget anse vara oriktig. Enligt Kungl. Maj:ts förslag måste man däremot kriminalisera den handlingen, att läkaren tar emot en högre summa, en tia mer eller något sådant, än vad som står i taxan. Det slipper man ifrån genom utskottets förslag. Det är väl ändå en stor fördel, att man ej inför straffrättsliga regler på det här området. Vi ha ju tillräckligt mycket förbud ändå utan att behöva införa förbud för läkare att taga emot en högre avgift av en patient än den, som angives av den obligatoriska taxan. Jag tror, att det skulle strida mot det allmänna rättsmedvetandet att göra detta.

Så måste jag säga några ord även om reservanternas yrkande. Det finnes

ju inga reservanter från första kammaren men väl från andra kammaren vid "tl

den nu omtalade punkten. Dessa reservanter vilja, att i lagen skall fastslås, att den regeln skall gälla, att läkaren ej skall få mottaga någon ersättning av de patienter, som vårdas på sjukhuset. Det vore väl ändå ganska djärvt att nu taga det steget. Det finnes ingen som helst utredning om de ekonomiska konsekvenserna för landstingen av ett sådant beslut. Det finnes väl dessutom ingen anledning att inskränka landstingens självbestämningsrätt i denna punkt. Herr Reuterskiöld, som är en varm vän av landstingens självstyrelse, vilket han även framhöll i sitt anförande, borde åtminstone hysa åtskilliga betänkligheter mot att följa reservanterna ur denna synpunkt. Men det finnes en annan icke mindre viktig synpunkt, som talar emot reservanternas förslag, och det är den, som herr statsrådet redan påpekat. Han framhöll nämligen, hur viktigt det är, att man håller lasarettsläkarkåren uppe på den höga ståndpunkt, som den för närvarande intager. Jag vill för min del tillägga. att jag tror, att de patienter, som ligga på halvenskilt eller enskilt rum, hellre betala ett honorar till en skicklig lasarettsläkare än de dö under vetskap om att stärbhuset slipper ifrån att betala något honorar.

Överhuvud taget förefaller det mig ofta, som om man i vårt land ej satte tillräckligt värde på den stora förmån, som vårt folk har därigenom, att vi åstadkommit ett sjukhusväsen av den förstklassiga beskaffenhet, som vårt land verkligen har. Det förefaller, som om man alltför litet insåge, hur angelägen man bör vara om att bevara detta, som man så lätt kan förstöra, och att man bör akta sig för att vidtaga åtgärder, som kunna sänka nivån av vårt sjukhusväsen. Det är i alla fall så, att ett sådant sjukhusväsen är ett ytterst invecklat och ömtåligt instrument till folkhälsans befrämjande, och gör man några oförsiktiga ingrepp i det, så kan därav åstadkommas konsekvenser, som bli ytterst beklagliga.

Ur denna synpunkt måste man naturligtvis vara försiktig också, när det gäller att lagstifta i fråga om läkarnas tillsättning. Herr Reuterskiöld yttrade, att förslaget alltför mycket beskurit sjukhusdirektionens rätt att giva förord. Enligt förslaget får, som vi veta, direktionen icke giva sitt förord åt vilken som helst av de sökande, utan för att den skall få giva någon sitt förord, fordras att denne erhållit åtminstone en röst vid omröstningen inom medicinalstyrelsen. Den siste ärade talaren sade, att direktionen i stället bör ha fri rätt att föreslå »efter hjärtats övertygelse». Ja, vi veta verkligen, att det är en grund, som direktionen ofta följer, och att det beror på, att dess ledamöter personligen lärt känna en hygglig man, som tjänstgjort på orten. Han har blivit god vän med dem och hjärtats övertygelse säger dem, att han är mycket lämplig att bli lasarettsläkare, och så ge de honom sitt förord. Men direktionen har ju ej tillfälle att överskåda hela det fält av sökande, som anmält sig, och att objektivt bedöma vilken av dem, som kan vara den värdigaste. Det ligger dock en oerhörd vikt vid att tillsättningen av lasarettsläkartjänsterna är så ordnad, att den värdigaste får platsen.

Den ärade talaren hänvisade till de regler, som gälla i fråga om prästval. Där förekommer ju även, att hjärtats röst övar inflytande både på den **kvinnliga**[1] och manliga sidan inom församlingen. Men vi veta alla, att den tjänstemannakåren är synnerligen litet belåten med de resultat, som där uppkomma. och klagar över ovissheten i församlingens utslag. Jag tror, att det vore synnerligen olämpligt, om man skulle jämställa lasarettsläkarna med prästerna med hänsyn till ovissheten i deras befordringsutsikter.

I varje fall vill jag säga, att om jag kommer såsom patient till ett sjukhus för att undergå en allvarlig operation, så vill jag mycket hellre opereras av en läkare, som blivit utsedd inom en krets av kirurger, som gillats av de sakkunniga,

än jag vill opereras av en person, som av de sakkunniga ansetts vara mindre framstående men som haft förmånen att äga några hjärtliga vänner inom direktionen.

Jag tror alltså, att man inte bör gå längre än vad utskottsförslaget gjort i syfte att möjliggöra för lekmännen att öva inflytande på lasarettsläkarnas tillsättning.

De anmärkningar, som kunna riktas mot det föreliggande förslaget, röra i allmänhet detaljer. Förslaget har enligt min mening betydande förtjänster och är ägnat att vara en lämplig grund för en framtida utveckling på sjukhusväsendets område. Med stöd härav, herr talman, ber Jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.